

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062063-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: VERA MARIA VOGEL BORGES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. O ORA PLEITEADO É REQUERIDO EM POR MÉDICO PARTICULAR, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO CORPO MÉDICO DO EXÉRCITO. PORTARIAS Nº 653/2005 E Nº 48/2008. ATENDIMENTO DOMICILIAR SERÁ PRESTADO SOMENTE POR PRESCRIÇÃO DE MÉDICO MILITAR OU, NA SUA AUSÊNCIA, POR PSA CREDENCIADO. ATENDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO QUE NÃO FOI PRESCRITO POR MÉDICO MILITAR OU POR PSA CREDENCIADO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se,, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5062063-64.2024.4.02.5101

510014382377 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062063-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: VERA MARIA VOGEL BORGES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face de decisão do Juízo *a quo* que deixou de conceder a tutela de urgência.

Pretende a parte autora que a ré preste os serviços de assistência domiciliar home care, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para:

- a) Inclusão de técnico de enfermagem para assistência diária (turno de 12 durante o dia);*
- b) Enfermagem periódica para avaliações;*
- c) Fonoaudiologia diária;*
- d) fisioterapia motora e respiratória diária;*
- e) ambulância equipada com equipe médica para consultas e exames complementares;*
- f) disponibilização de fraldas geriátricas, luvas descartáveis para a manipulação da paciente e espessante para dieta via oral;*
- g) Consulta com especialista em pneumologia para avaliação da lesão;*

Informa a recorrente ter 70 (setenta) anos de idade e que, em função do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico agudo sofrido, foi submetida a trombectomia de artéria cerebral média direita no Hospital Beneficência Portuguesa (SMH), em Petrópolis, e que depois

foi transferida para o Hospital Geral do Exército, no Rio de Janeiro. Informa ter recebido alta em 29/05/2024 e que encontra-se, desde então, acamada com afasia motora e déficit motor no hemisfério esquerdo do corpo.

Alega que a documentação emitida pela médica do exército (evento 1, OUT6), é firmada pela Dra. Isabela Carine Ramos Nascimento cuja especialidade é geriatria, e que necessita de atendimento por médico especialista em neurologia. Alega ainda, que a Dra. Isabela solicitou acompanhamento especializado de neurologia, e que tal pedido jamais foi atendido pelo Fusex, que enviou apenas um Nefrologista (especialidade que cuida aparelho urinário).

Por essa razão, alega que sua a filha buscou acompanhamento especializado e, assim, o Dr. Antônio Henrique Nunes Ribeiro, neurocirurgião, passou a acompanhá-la, vistas a dar o tratamento adequado para sua reabilitação, bem-estar e dignidade.

Decisão do evento 3, indeferindo a liminar.

Decisão do evento 12 que mantem a decisão do evento 3.

VOTO

Tendo em vista que o quadro fático permanece o mesmo, mantenho o já decidido no evento 3, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Observa-se dos autos que a parte autora recebeu alta hospitalar com as seguintes orientações:

ALTA MÉDICA:

- Retomar uso da Valsartana 160mg 12/12h
- Manter anlodipino 5mg 12/12h
- AAS 100mg + Atorvastatina 40mg
- Rivaroxabana 20mg 01cp ao dia
- Sulfato ferroso 40mg/dia
- Encaminhamento ao Gerenciamento de pacientes crônicos
- Solicito fisioterapia motora
- Solicito Fonoaudiologia
- Dieta pastosa + líquida com espessante até reabilitação
- Solicito doppler de carótidas
- Encaminhamento para Neurologia

Orientações

ALTA MÉDICA:

- Retomar uso da Valsartana 160mg 12/12h
- Manter anlodipino 5mg 12/12h
- AAS 100mg + Atorvastatina 40mg
- Rivaroxabana 20mg 01cp ao dia
- Sulfato ferroso 40mg/dia
- Encaminhamento ao Gerenciamento de pacientes crônicos
- Solicito fisioterapia motora
- Solicito Fonoaudiologia

Isabela Carine Ramos Nascimento
1º Ten Med CRM 52.812-2/541-1 RJ
Idt Militar 060.406.807-2 MD/EB

MINISTÉRIO
EXERCITO
CM
HOSPITAL GERAL

P/ VERA MARIA VOGEL BORGES,

Solicito: Fisioterapia do PAD

Justificativa: Sequela de AVE isquêmico

Rio de Janeiro, 29/05/2024

Isabela Carine Ramos Nascimento
1º Ten Med CRM 52.812-2/541-1 RJ
Idt Militar 060.406.807-2 MD/EB

P/ VERA MARIA VOGEL BORGES

Solicito: Fonoaudiologia do PAD

Justificativa: AVE isquêmico, dificuldade de deglutição

Rio de Janeiro, 29/05/2024

Isabela Carine Ramos Nascimento
1º Ten Med CRM 52.812-2/541-1 RJ
Idt Militar 060.406.807-2 MD/EB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CML – 1ª RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

À Neurologia,

Encaminho paciente VERA MARIA VOGEL BORGES, 70 anos. Paciente portadora de HAS evoluiu com AVE isquêmico, tendo feito trombectomia de artéria cerebral média direita. Solicito acompanhamento especializado.

Grata,

Rio de Janeiro, 29/05/2024

Isabella Carine Ramos Nascimento
En Med CML 20129541-1 RJ
14-2-2018 405.507-2 MD/EB

De fato, não há menção à frequência do atendimento fisioterápico e fonoaudiológico. Também não foi orientado a inclusão de técnico de enfermagem para assistência diária. Tais orientações poderão surgir após consulta com médico especializado em neurologia.

Apesar de o encaminhamento ter sido realizado em 29/05/2024, a parte autora alega que ainda não foi marcada consulta. A parte ré ainda não se manifestou nos autos, estando ainda aberto o prazo para contrarrazões.

Observa-se, no entanto, que em sua inicial a parte autora não pretende a marcação da consulta com médico especializado dentro do FUSEX, mas pretende se valer de prescrição de médico particular.

O sumário da alta do Hospital do Exército, registra internação após realização de Trombectomia de artéria cerebral média direita em outra instituição, tendo havido alta em 29/5/2024 (evento 1 out 2, pag 3). Ao passo que, o ora pleiteado é requerido em 15/07/2024, por médico particular (evento 1 out 3). Sem qualquer manifestação do corpo médico do Exército.

De acordo com as Portarias nº 653/2005 e nº 48/2008, destacadas na decisão do Juízo a quo, o atendimento domiciliar será prestado somente por prescrição de médico militar ou, na sua ausência, por PSA credenciado. O atendimento médico pretendido não foi prescrito por médico militar ou por PSA credenciado.

Portaria nº 653/2005

Art. 11. São benefícios concedidos aos beneficiários do FUSEX:

(...)

§ 5º O atendimento domiciliar será prestado somente por prescrição de médico militar ou, na sua ausência, por PSA credenciado, quando houver impossibilidade ou inconveniência técnica de remoção para uma organização de saúde.

Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO HOME CARE. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNICÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. Com efeito, não há nos autos - pelo menos até o momento - elementos probatórios suficientes para evidenciar, de pronto, a necessidade e urgência da disponibilização de serviço de home care à agravante, por intermédio do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), e a inadequação da internação hospitalar (convencional) para o seu tratamento médico. 2. A situação fática reclama dilação probatória (até para ser contraditado o laudo médico particular) e cognição exauriente, devendo prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor do ato administrativo impugnado. (TRF-4 - AG: 50057371720184040000 5005737-17.2018.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/06/2018, QUARTA TURMA) (Grifo nosso).

Assim, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão que deixou de conceder a tutela de urgência, diante da necessidade maior instrução.

Diante das importantes informações trazidas pelo médico que trata a autora (médico neurocirurgião) pelo tempo transcorrido entre o laudo do Exército e o atual laudo particular e, considerando ainda que o passar de tempo pode ocasionar modificação, com piora do quadro clínico de saúde da recorrente, ou até mesmo estabilização, revela -se que tal deve ser objeto de instrução nos autos principais, com realização de perícia judicial, envio de ofício para esclarecimentos junto ao médico militar, ou determinação de complementação pela parte autora, como entender adequado o juízo *a quo*. O que pode ainda ser feito pelo Juízo a quo.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se,